

L'importance du questionnement du projet de vie, dans les services généraux, des patients présentant des pathologies engageant leur pronostic vital à court ou moyen terme.

Travail de fin d'études présenté
pour l'obtention du grade académique de
Bachelier : Infirmier Responsable de soins généraux
par

REMY Lise
Juin 2022

Je tenais à remercier ma promotrice, Madame Maucq, pour ses conseils, son soutien et ses encouragements. Elle a su me guider dans la construction et la rédaction de ce travail.

Un grand merci également aux infirmières qui ont accepté de participer à mon enquête exploratoire. Pouvoir discuter de ce sujet avec elles a été un réel plaisir et très enrichissant.

Enfin un énorme merci à mes proches, famille et amis, qui m'ont soutenue tout au long de la rédaction de ce travail de fin d'études. Ils ont su faire preuve de patience et d'écoute. Ils ont toujours été là dans les moments de doute et de découragement afin de me remotiver. Leurs critiques et relectures ont été d'une aide précieuse.

Mots- clés :

Projet de vie

Accueil

Accompagnement

Table des matières

Introduction.....	5
1. Constat(s), interpellation(s) et ancrage à la discipline infirmière.....	6
2. Recherches et réflexion professionnalisante.....	13
3. Synthèse, questionnement professionnel et pistes de réflexion	24
Conclusion personnelle	26
Liste de références	28
Annexe 1 : Go Wish (Carlin, 2017, pp. 93-94)	31

Introduction

Le choix de cette thématique m'est venu lorsque j'effectuais des nuits en tant que jobiste durant les vacances de Pâques 2021. Lors d'un moment creux, l'infirmière et moi avons commencé à discuter des projets thérapeutiques chez les patients et la rare mise en place de ceux-ci dans les services. Elle m'expliqua qu'il arrivait également que ceux-ci soient mis en place trop tard, le patient se dégradant vite au fil des jours. Cela ne permettait donc pas de respecter les désirs de celui-ci comme rentrer chez lui afin d'être entouré de ses proches. Cette conversation m'a rappelé une situation que j'ai vécue lors d'un précédent stage.

Cela m'a donné envie d'en savoir plus sur le rôle de l'infirmière dans la mise en place de projets thérapeutiques, ainsi que sur l'ensemble des procédures existantes où elle peut agir afin de connaître et de mettre en place les volontés de soins du patient.

De plus, pour moi, il est également très important d'être à l'écoute du patient et de l'accompagner afin de connaître son projet de vie et de respecter ses choix. Je pense qu'il est primordial d'installer une relation de confiance entre le soignant et le soigné.

C'est pour ces raisons que j'ai décidé de travailler sur cette thématique en particulier au travers de ce travail de fin d'études (TFE).

Pour ce faire, je vais vous proposer un plan expliquant la manière dont ce travail a été construit. Tout d'abord, je vous relaterai une situation vécue en stage qui m'a interpellée. Ensuite, je vous exposerai les différents concepts qui ont émergé de cette situation. Afin de construire mon cheminement de pensée, j'ai effectué une analyse d'article probant ainsi qu'une enquête exploratoire qui m'ont permis d'aboutir à un questionnement professionnel que j'énoncerai ultérieurement. Pour finir, je terminerai par une conclusion où un feedback de mon travail sera abordé.

1. Constat(s), interpellation(s) et ancrage à la discipline infirmière

La situation qui m'a interpellée, je l'ai vécue lors d'un de mes stages de troisième année dans un service de chirurgie orthopédique et d'oncologie. Il s'agit d'une dame âgée de 86 ans, entrée le 18 janvier 2021 en urgence pour nausées et vomissements fécaloïdes. Les antécédents médicaux de cette patiente sont plusieurs cancers dont un du sein et un du côlon en phase terminale diagnostiqué quelques mois auparavant (en septembre). Celui-ci ne répondait à aucun traitement curatif. Après divers examens pratiqués aux urgences, le diagnostic posé a été une occlusion intestinale ainsi que l'extension de son cancer métastasé au niveau du foie. Une laparotomie fut réalisée afin de lever l'occlusion intestinale et une sonde naso-gastrique de décharge fut mise en place. Elle fut hospitalisée dans le service ensuite, aucune anamnèse supplémentaire ne fut réalisée, le personnel soignant jugeant suffisante celle faite aux urgences. Son accueil dans le service fut donc assez bref. Plus de trois semaines après son entrée, soit le 9 février 2021 à 9h30, j'ai pris le relais pour la réalisation des soins d'hygiène de cette patiente, l'aide-soignante s'en occupant allant en pause. Si un souci survenait, ma consigne était de demander de l'aide.

Pendant que je déshabillais Madame, celle-ci fut prise brutalement de fortes bouffées de chaleur. Je me suis empressée de lui demander si je pouvais ouvrir la porte afin que de l'air frais puisse entrer dans la pièce. Elle accepta. Le temps d'aller à la porte suffit pour retrouver ma patiente affaissée, les yeux grands ouverts sur les toilettes. Inconsciente, elle ne répondait plus à l'appel de son nom. En toute hâte, j'ai appuyé sur la sonnette d'urgence. Malgré ce geste et ne voyant personne arriver, je me suis rendue dans la salle de soins pour référer de la situation. Les infirmières sont alors immédiatement venues en chambre me prêter mains fortes.

Une fois rentrées dans la chambre, celles-ci ont réinstallé Madame dans son lit tout en l'appelant par son prénom et en la secouant. C'est à cet instant qu'une infirmière se demanda si Madame était NTBR (not to be Reanimated) et quel était son projet thérapeutique, ce qu'elle désirait réellement. Celle-ci n'ayant pas d'information sur les souhaits de Madame, elle décida d'aller voir dans le dossier informatisé de la patiente si le document destiné au projet thérapeutique était complété. Elle ne trouva rien dans son dossier médical. L'infirmière en informa l'ensemble de ses collègues présentes dans la chambre. Heureusement, quelques instants plus tard, Madame est revenue à elle sans qu'on doive la réanimer. Lors des semaines qui ont précédé cet événement, Madame n'avait pas laissé transparaître ce qu'elle souhaitait

vis-à-vis de son hospitalisation. Le personnel soignant ignorait ce que la patiente savait de sa maladie et du stade de celle-ci. De plus, il ne lui a pas demandé non plus ce qu'elle attendait de son hospitalisation sachant qu'elle était en phase terminale de son cancer. Durant ces semaines, Madame avait des moments où elle était au plus bas, où l'on devait effectuer sa toilette complète au lit, où elle ne s'alimentait plus, ce qui a nécessité la mise en place d'une voie centrale et de l'alimentation parentérale. A contrario, il arrivait qu'elle effectue sa toilette à l'évier seule et qu'elle se sente en pleine forme.

Son petit-fils venait régulièrement lui rendre visite, il y avait une relation fusionnelle entre eux. Ils vivaient et travaillaient ensemble dans le restaurant familial. Celui-ci venait la voir tous les jours et lui disait de se battre jusqu'au bout espérant que les médecins trouvent un moyen de la guérir.

À la suite de cette situation, une infirmière du service a interpellé l'oncologue afin qu'elle aille voir la patiente et son petit-fils pour leur expliquer les différentes options possibles dans la situation de Madame (mise en place d'un projet thérapeutique dans le service, rentrer chez elle près de ses proches). L'après-midi même, l'entrevue a eu lieu dans la chambre de la patiente en présence de son petit-fils. Le lendemain, l'oncologue nous a fait un feedback de la réunion. Elle nous a expliqué que le petit-fils était réticent à la mise en place d'un projet thérapeutique car il craignait qu'on laisse sa grand-mère mourir et qu'elle puisse souffrir. Le médecin lui a donc expliqué tout ce qui pouvait être fait lorsqu'un patient décidait de la mise en place d'un projet thérapeutique et les différents niveaux de soins. Ce qui en est ressorti est le désir de Madame de ne pas être réanimée ainsi que le désir de pouvoir retourner chez elle, finir ses jours, entourée des siens dans sa maison.

Cela n'a hélas pas été possible car Madame étant très affaiblie, le transport en ambulance était trop risqué selon l'oncologue. De plus, l'assistante sociale n'a pas eu le temps de mettre en place le matériel nécessaire à domicile pour la patiente (lit médicalisé, équipe d'infirmières à domicile, ...) Madame est décédée à l'hôpital deux jours plus tard.

Lors de cette situation, j'ai pu observer ce que les infirmières avaient fait. Tout d'abord, j'ai pu constater que l'équipe avait repris l'anamnèse faite par les urgences, à savoir le motif d'hospitalisation, les paramètres à l'entrée, les antécédents médicaux et les traitements du domicile ainsi que les examens effectués en urgence étant donné la situation critique lors de l'hospitalisation. Personne n'a questionné la patiente lors de l'accueil dans le service afin de connaître son ressenti face à la situation qu'elle venait de vivre, ainsi que ses attentes vis-à-vis

de son hospitalisation. Toutefois, elle n'a, elle-même, rien laissé transparaître sur celles-ci. Cependant, l'équipe soignante savait que le petit fils espérait toujours que l'on puisse guérir sa grand-mère et lui demandait continuellement de se battre contre son cancer.

Tout d'abord, ce qui m'a interpellée dans cette situation, est le fait que Madame n'a jamais laissé transparaître ses émotions vis-à-vis de son cancer, ni parlé de ses projets au personnel soignant. Ensuite, c'est le fait qu'il ait fallu que Madame fasse un malaise pour que le personnel soignant s'interroge sur ses volontés alors qu'elle était dans le service depuis plus de trois semaines. Elle était atteinte d'un cancer stade terminal pour lequel sa dernière cure de chimiothérapie n'avait pas été concluante. Lors de son hospitalisation, aucun traitement curatif n'était prévu par l'oncologue. Son état de santé pouvait laisser penser qu'un problème vital pouvait arriver. C'est donc au pied du mur que le projet thérapeutique a été élaboré, malheureusement trop tard pour que les désirs de Madame puissent être mis en place.

Cette situation m'a donc amenée à m'interroger sur différents points. Tout d'abord sur le fait que les infirmières n'ont pas envisagé le besoin ou la nécessité de questionner Madame sur ses souhaits quant à sa fin de vie. Ensuite, sur les connaissances de la patiente par rapport aux différents projets existants.

Ce constat m'a amenée à me renseigner sur ce que disait la loi sur les différentes compétences de l'infirmière dans l'élaboration de projets et la prise en charge du patient.

Tout d'abord au niveau de la loi, dans le code de déontologie des praticiens de l'art infirmier (Union Général des Infirmiers de Belgique, 2004, mis à jour par le conseil fédéral de l'Art infirmier en 2017, p.9), l'article 30 nous dit que :

L'infirmier échange les données nécessaires, partage ses observations et se concerta avec le médecin et les autres prestataires des soins sur l'état, le traitement et l'évolution du bénéficiaire. Il collabore activement à une approche interdisciplinaire des soins et traitements au bénéficiaire. Si besoin en est, il fait une proposition argumentée pour une concertation et/ou une adaptation du traitement.

Dans cet article du code de déontologie, on peut voir que l'infirmière doit se concerter avec le médecin et les autres prestataires de soins afin de communiquer des informations pertinentes sur l'état de santé du patient et sur les traitements à adopter. Dans ma situation, aucun membre de l'équipe ne s'est enquis des volontés de soins de la patiente alors que celle-ci se dégradait au fil des jours. Il a fallu que Madame fasse un malaise pour que le personnel soignant consulte

le dossier à la recherche d'informations sur ses souhaits. En l'absence de celles-ci, elle a pris l'initiative de solliciter le médecin pour que celui-ci rencontre Madame et l'interroge sur ses désirs pour la suite de son hospitalisation.

Je me suis ensuite intéressée aux différentes compétences de l'infirmière reprises dans le référentiel de compétences de la Haute Ecole Robert Schuman (HERS) afin de mettre en évidence celle nécessaire à la mise en place de projets.

La compétence que j'ai mise en évidence est la compétence 2 :

Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires et plus précisément la 2.2.1 : s'enquiert des demandes et préférences du patient et les respecte et la 2.2.4 : s'enquiert du projet de la personne concernant sa santé et le respecte (HERS, 2020-2021, p.2).

Cette compétence indique qu'il est du rôle de l'infirmière de s'informer, se renseigner sur les désirs et les projets du patient concernant sa santé. Dans cette compétence, on parle du projet du patient au sens large. On ne distingue pas les différents types de projets existants et possibles à mettre en place chez les patients. J'ai donc décidé de développer les principaux afin de mettre en évidence celui qui est le plus en lien avec ma thématique.

Fort de ces informations sur le rôle de l'infirmière, j'ai alors effectué des recherches afin de connaître les différents types de projets qui peuvent être mis en place pour les patients.

Tout d'abord, qu'entend-on par projet ?

Selon Le Petit Larousse Illustré (2012, p.884), un projet se définit comme « ce que l'on a l'intention de faire, un plan ».

Il s'agit donc de ce que l'on aimerait accomplir dans le futur (plus ou moins proche) afin d'atteindre un but.

D'un point de vue « médical », on peut répertorier quatre types de projets principaux.

Commençons par le projet thérapeutique qui a été abordé dans ma situation :

Selon Claes et al. (2019, p.4), le projet thérapeutique permet de répondre, en équipe et en restant à l'écoute du patient, à la question « que faire pour bien faire ? ». Il permet de se poser dans des situations où il est difficile d'y voir clair. Il est essentiel de le

déterminer ensemble : soignants et patient. Il est utile de contacter également le médecin traitant pour le remettre dans le contexte des soins déjà reçus. Le projet thérapeutique reflète les souhaits de fin de vie du patient. Il permet d'éviter les traitements dépourvus de sens. Il améliore la cohérence de la prise en charge et de la communication au sein de l'équipe et de la famille.

De plus selon Vayene - van Gost (2019, dia 32), un projet thérapeutique consiste également à : décider du niveau d'intensité des soins qui seront prodigués en cas de détérioration aiguë de l'état du patient, et par là de l'arrêt ou de la non mise en œuvre de certains traitements. Celui-ci relève du choix du médecin en concertation avec le patient et ses proches, fait référence à un protocole de soins et est évolutif.

On peut donc constater que le projet thérapeutique doit s'établir en concertation entre l'équipe soignante et le patient ainsi que sa famille. Son élaboration, qui évoluera au fil du temps et de la maladie, doit permettre d'éviter tout acharnement thérapeutique si telle est la décision du patient. Dans ce projet, on aborde plus spécifiquement l'aspect médical. L'infirmière ne construisant pas elle-même ce projet, elle est plutôt un relais entre le patient et le médecin, je ne le retiendrai pas pour ma situation. Il fait cependant partie intégrante d'autres types de projets, à savoir le projet de soins, le projet de soins personnalisés et anticipés ainsi que le projet de vie.

Débutons par définir chacun de ces projets :

Tout d'abord, le projet de soins :

[...] (il) suppose une identification des problèmes de santé et des ressources de la personne soignée et de ses proches. L'élaboration de ce projet de soins infirmiers implique une collaboration pluridisciplinaire professionnelle. La personne soignée et ses proches seront sollicités pour l'élaboration de ce projet. Ce projet de soins infirmiers individualisé est un processus dynamique qui évolue. Il sera réajusté en fonction de l'état de santé, des besoins et des souhaits de la personne soignée (Breuil et al., 2001, cité dans Guerrin, 2012, p. 317).

Quant au projet de soins personnalisés et anticipés (PSPA), celui-ci est défini comme :

Un processus par lequel une personne en concertation avec ses proches et ses soignants, formule à l'avance des objectifs et des choix relatifs à la manière dont elle souhaite que

l'on prenne soin d'elle si elle n'est plus en mesure de les assumer elle-même. Ce processus peut aboutir sur les directives anticipées. Il s'agit ici d'une demande officielle faite par le patient (La fondation du Roi Baudouin et le pallium, s.d., cité dans Hebblinck et Hupé, 2020, dia 12).

De plus, selon le dictionnaire médical (s.d.)

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée « directive anticipée » pour préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, afin d'anticiper au cas où elle ne serait plus capable de les exprimer. Ce document permettra au corps médical de prendre, le moment venu, des décisions adaptées aux souhaits du patient, et donc d'éviter de mettre en œuvre des mesures qui pourraient passer pour de l'acharnement thérapeutique.

Enfin, pour terminer, j'en viens au projet de vie.

Selon Loubat (2010, p.1), le projet de vie est l'expression de la projection dans l'avenir de la personne malade et l'expression de ses aspirations et de ses choix. Le projet de vie donne du sens à ce que vit la personne. Elle est une « orientation vers » et non pas un « bilan sur ». Le projet de vie est donc par définition personnel et singulier, dépendant de ce que vit et de ce qu'a vécu la personne malade, de son ressenti (lien entre passé-présent-futur). Il est aussi évolutif : il ne peut être figé et n'est le reflet que d'un moment de l'existence. Il peut aussi recouvrir différents aspects de la vie : vie professionnelle, personnelle, lieu de vie et parcours médical.

Fort de ces renseignements concernant ces trois projets, je peux constater qu'ils sont liés les uns aux autres. Il y a des similitudes entre autres sur l'aspect collaboratif et évolutif de ceux-ci. En effet, le patient ainsi que sa famille doivent discuter des souhaits avec l'équipe médicale. De plus, rien n'est figé, des modifications pourront toujours être apportées au fil du temps suivant l'évolution de la maladie ou des désirs du patient.

Cependant, le projet de soins personnalisés et anticipés étant un projet qui est formulé à l'avance au cas où le patient ne serait plus à même d'exprimer ses choix, je ne le retiendrai pas non plus car il n'est pas en lien avec ma situation.

Dans mon constat, ce sont plus les aspects du projet de vie qui n'ont pas été abordés que je retiendrai, à savoir le fait que l'infirmière doit s'enquérir des souhaits du patient pour l'avenir,

ce qu'il souhaite tant au niveau des soins que de la vie qu'il désire mener à court ou moyen terme. En effet, grâce au projet de vie, l'infirmière saura quelles sont les aspirations et les choix du patient ainsi que son ressenti face à la maladie. Elle aura alors les informations nécessaires à l'élaboration du projet de soins qui pourra changer au fil de l'évolution de la maladie. Le projet de vie reprend tous les aspects de la vie du patient, tant personnel, professionnel que médical.

Dans ma situation, aucun membre de l'équipe ne s'est informé sur les désirs de la patiente. Personne ne connaissait son projet de vie, ce qui pourtant fait partie du rôle de l'infirmière, à savoir s'interroger sur les volontés du patient. Ce n'est qu'après son malaise que le nécessaire a été fait.

A l'issue de ces recherches, mon interpellation se portera donc sur le rôle de l'infirmière dans le questionnement du projet de vie, plus précisément connaître le plus rapidement possible les souhaits pour l'avenir des patients présentant des pathologies graves laissant penser à une fin de vie à court ou moyen terme. En effet, dans ma situation, le personnel soignant n'a pas cherché à connaître le projet de vie de la patiente lors de son entrée dans le service alors que son état de santé laissait présager le pire.

2. Recherches et réflexion professionnalisante

Dans cette seconde partie, j'analyserai les différents concepts issus de mes constats et interpellations. Afin d'approfondir mon cheminement de pensée, j'analyserai un article probant. Enfin, je procèderai à une enquête exploratoire dont je rédigerai le compte-rendu et l'analyse.

Commençons par l'analyse du premier concept qui a émergé de ma réflexion : le projet de vie. Celui-ci peut être défini comme suit :

Le projet de vie prend en compte toute la personne dans ses besoins, ses ressources, ses désirs, ses envies, et son entourage dans le contexte de « sa » vie. Le projet de vie de la personne se développe donc dans toutes ses dimensions du soin et du prendre soin autour et à travers tous les besoins Virginia Henderson. (Halouët, 2019, p.441)

« C'est une représentation mentale de la vie que le patient souhaite mener et des moyens qu'il se donne pour y parvenir » (Réseau universitaire intégré de santé de l'université de Montréal [RUIS], 2014, cité dans Fortin, 2017, p.1)

« Le projet de vie sert de guide à l'individu dans l'adoption de ses comportements et de ses choix, et évolue en fonction du temps et des événements qui marquent son parcours, et ce, jusqu'aux derniers instants de sa vie ». (RUIS, 2014, dans Fortin, 2017, p.1)

Il s'agit donc l'existence à laquelle le patient aspire, ainsi que les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Les événements vécus ainsi que son état de santé évoluant au fil du temps, il est clair que le projet de vie devra lui aussi évoluer afin de toujours rester le plus en phase possible avec ses désirs et souhaits.

Par ailleurs, en fin de vie, il est souvent plus facile d'aborder avec le malade son projet de vie sous l'angle de ses besoins et attentes à court terme, par exemple le soulagement de souffrances physiques, la récupération de la mobilité ou de la communication afin de maintenir une relation avec des proches significatifs (RUIS, 2014, dans Fortin, 2017, p.1)

Le projet de vie prend donc un sens différent selon les étapes de la vie du patient.

Le public cible nécessitant son élaboration est :

« Toute personne souffrant d'une maladie grave, évolutive, en phase avancée, potentiellement mortelle ou lorsqu'une situation met en jeu le pronostic vital à court ou moyen terme (suite à un accident par exemple) [...] ». (Haute Autorité de Santé, 2018, p.2)

Chez le patient présentant une maladie grave en phase avancée dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, le projet de vie prend donc tout son sens car il lui permet de rester maître de son destin. Jusqu'au bout, il pourra décider de ce qu'il veut tant au niveau des soins que de ses désirs (rentre chez lui, effectuer un dernier voyage, ...). Plus tôt il sera questionné et plus vite il pourra être mis en place. Il est évident que plus la maladie sera avancée et plus les besoins et attentes seront établis à court terme.

Il est donc important de parler de projet de vie avec une personne en fin de vie ou gravement malade.

Coitout et Lavault diront que parler et construire un projet de vie souligne la vie qui est encore présente et qu'il faut encore exploiter [...] Elaborer et mettre en œuvre un projet ne sera pas une perte de temps. [...] Le projet va lui permettre d'être considéré comme vivant, comme acteur de sa vie même si cette dernière fuit peu à peu. [...] Il est porteur de sens lequel est essentiel en fin de vie (2021, p.2).

Ce questionnement peut au départ se faire à des moments charnières de la maladie du patient comme lors de l'annonce du diagnostic ou lors de l'avancée du traitement. Cependant, toute pathologie évoluant, le projet de vie du patient devra tenir compte de la spécificité de celle-ci afin que l'accompagnement du patient soit optimum (Jamet, 2006)

Dans ma situation, le personnel soignant ne s'est pas questionné assez rapidement sur ce que la patiente attendait de son hospitalisation, celle-ci se trouvant pourtant dans le cadre d'une fin de vie potentiellement proche. La mise en place de ses souhaits n'a donc pas été possible.

Afin de connaître le projet de vie du patient, celui-ci devra répondre à des questions sur ses désirs, son environnement et son entourage. Celui-ci est primordial car le patient, avec l'évolution de la maladie, sera de plus en plus dépendant de lui. Si une modification devait

arriver dans cet entourage proche, inévitablement le projet de vie devrait être remanié (Jamet, 2006).

Ces recherches sur le projet de vie m'ont poussée à m'interroger sur ce qui était fait dans différents services quant au questionnement du patient et surtout quand cela était fait. J'ai donc essayé de trouver une étude qui reprenait cet aspect. L'étude trouvée lors de ma recherche documentaire l'a été sur le moteur de recherche Google Scholar. Mon but était de savoir si des études avaient été réalisées sur le projet de (fin de) vie et le rôle de l'infirmière. S'il était mis en place et quand il l'était. J'ai au départ indiqué les mots clés : fin de vie. Aucun résultat intéressant n'est ressorti de cette recherche. J'ai alors indiqué : fin de vie – rôle soignant. Les résultats obtenus ont été nettement plus en adéquation avec ma thématique. Un article a particulièrement retenu mon attention : « Le rôle décisionnel chez les patients hospitalisés gravement malades en fin de vie : la perspective du patient et celle du soignant » par J.E. Tranmer et D. Heyland. Bien que cet article parle plus particulièrement du projet thérapeutique, celui-ci fait cependant partie intégrante du projet de vie, il était donc intéressant que je l'analyse. Il y est également fait état du point de vue du soignant et c'est aussi cela qui a retenu mon attention.

Les deux auteurs sont professeurs à la Queen's university et chercheurs. Le Dr Tranmer est également directrice de la recherche infirmière au Kingston General Hospital. Le Dr Heyland est intensiviste médical et scientifique de carrière. La qualité des soins en fin de vie est un sujet de recherche qui les intéresse particulièrement.

Cette étude s'inscrit dans un contexte où les patients atteints de cancers ou gravement malades doivent prendre de plus en plus souvent des décisions quant à leur traitement. Cet aspect fait partie intégrante du projet de vie. Souvent, les soignants ne connaissent pas les préférences des patients en ce qui concerne les traitements de fin de vie ou ne cherchent pas à les connaître. Les objectifs de cette étude sont de déterminer les préférences des patients gravement malades quant à l'utilisation de traitement de survie, ainsi que leur rôle décisionnel et de déterminer si les soignants en avaient connaissance.

« Cette étude pilote prospective et descriptive » (Tranmer, Heyland, 2001, p.14) a eu lieu dans un hôpital d'enseignement de l'Ontario. Cent dix-sept patients hospitalisés et gravement malades ont été interrogés. On peut donc constater que cette population d'étude reprend bien le type de patients ciblés dans mon interpellation. Quant au personnel soignant, ce sont cinquante-trois infirmières et soixante-trois médecins traitant ces patients qui ont participé à

l'étude. Le rôle des soignants étant différent en Ontario par rapport à la Belgique, je ne retiendrai que les éléments transposables à ma situation, principalement quand le patient est-il questionné sur ses souhaits ?

Des questions similaires sur la fin de vie et sur les décisions face aux traitements de survie ont été posées à chaque partie, patients et soignants. Les résultats obtenus, suite aux questions posées aux patients sur la fin de vie, sont assez clairs. Plus de 77 % de patients cancéreux interrogés avaient déjà réfléchi aux types de traitements qu'ils aimeraient recevoir en cas de complications potentiellement mortelles. Mais dans cette étude, seuls 38% en avaient discuté avec le médecin et seulement 13 % avec une infirmière ou d'autres professionnels de la santé. La majorité des patients interrogés se disent cependant prêts à aborder le sujet avec leur médecin (71 %) ou d'autres professionnels de la santé (63%).

Lorsque l'on interroge les soignants, il en ressort que les infirmières, venant juste de prendre en charge le patient, sont mal à l'aise par rapport au fait d'aborder le sujet des soins de fin de vie, elles estimaient ne pas assez le connaître ou ne pas devoir le faire, ce sujet devant être abordé par les médecins. Ces derniers estimaient, eux, que cette tâche devait être faite par « quelqu'un d'autre » ou que l'état de santé du patient n'était pas assez préoccupant pour déjà en discuter. C'est ce constat de l'article qui a retenu toute mon attention car il se trouve être en lien avec ma thématique. Le questionnement du patient se fait trop tard.

Analysons les points importants de cet article. Tout d'abord, les patients hospitalisés et gravement malades se sont déjà interrogés sur les soins de fin de vie qu'ils souhaiteraient et sont tout à fait disposés à en discuter avec le personnel soignant. On constate donc que ce n'est pas un problème pour eux d'en parler. Il n'y a donc pas de souci à ce que les infirmières les questionnent beaucoup plus tôt. Comme déjà indiqué plus haut, ce questionnement sur les soins fait partie intégrante du projet de vie, même si ce n'est qu'une partie, elle est très importante. Dans ma situation, on peut supposer que Madame y avait déjà réfléchi car elle a directement donné ses volontés à l'oncologue quand elle l'a interrogée. L'infirmière peut donc être ici un relais entre le patient et le médecin.

Ensuite, le personnel soignant aborde le sujet soit de façon inappropriée soit tardivement ou a tendance à le faire quand une crise majeure se produit. Ici aussi, c'est lorsque Madame a fait son malaise que le nécessaire a été fait.

Enfin, pour le personnel infirmier, il est ressorti de cette étude que du fait de la charge de travail et de l'organisation, celui-ci axait la discussion avec le patient sur ses besoins immédiats, ne

laissant pas de place à une discussion proactive sur les soins de fin de vie. Dans la situation vécue, l'accueil et l'accompagnement de Madame se sont fait également afin de répondre à ses besoins immédiats, personne n'ayant initié le dialogue sur ses souhaits de fin de vie.

Cette tâche fait cependant partie du rôle de l'infirmière : s'enquérir des demandes et préférences du patient et les respecter, ainsi que s'enquérir du projet de la personne concernant sa santé et le respecter. Il me semble donc important de questionner le patient, quelle que soit la charge ou l'organisation du travail dans le service.

Tranmer et Heyland indiquent cependant que « fort peu de recherches ont explorés le rôle des infirmières au niveau des soins et de la prise de décision en fin de vie » (2001, p.14).

A la lumière de cet article, je constate que le questionnement des volontés des patients gravement malades est un sujet délicat à aborder pour les soignants. Bien que les patients aient déjà réfléchi à ce qu'ils veulent ou non comme traitements, ce qui fait partie intégrante du projet de vie, les infirmiers ne l'abordent pas ou trop tard. Interroger les patients à ce sujet ne leur semble pas être nécessaire, pas de leur ressort ou seulement quand une crise survient.

Pour combler ce « manque », Oliverio et Fraulo (1998, cités par Tranmer et Heyland, p.20) suite à leur étude SUPPORT, recommandent, « [...] que les discussions portant sur les questions relatives aux soins en fin de vie surviennent plus tôt dans tous les contextes de soins [...] ». Mais également la mise en œuvre de méthodes qui pourraient permettre aux patients et aux soignants de dialoguer sereinement quant aux soins de fin de vie.

L'accueil du patient dans le service pourrait donc être un moment clé afin de connaître ses désirs. J'ai de ce fait décidé d'analyser ce concept.

Selon Formarier (2012, p.43), « il peut être considéré comme la première étape de la prise en soin d'un patient dont il gardera un souvenir et qui peut influencer la suite des interactions de soin ».

Bourgeois dira que « l'entretien d'accueil a pour but d'établir une relation de confiance avec la personne soignée, qui doit se sentir attendue, reconnue et acceptée. [...] C'est un acte de soins infirmiers relevant du rôle propre, basé sur le dialogue et l'observation ». (2010, p.43)

La relation entre le soignant et le soigné sera influencée par cet accueil. Toute personne hospitalisée est en état de stress et peut rencontrer des difficultés à gérer ses émotions ainsi que la situation. Les soignants sont là afin de l'aider à extérioriser ses craintes et son ressenti.

L'accueil consiste donc à établir une relation symétrique soignant-soigné où chacun s'exprime. Le patient doit être partenaire dans la situation et le soignant doit le mettre en confiance afin qu'il puisse se sentir moins vulnérable et ose s'exprimer. Si cet accueil n'a pas lieu ou est fait de façon trop rapide, la relation restera asymétrique ce qui pourrait avoir comme répercussion un manque de communication. (Formarier, 2003)

Afin de faciliter ce questionnement certains outils existent. L'un d'entre eux, le GoWish créé par une association nord-américaine, Coda-Alliance, va permettre aux patients de classer leurs souhaits par ordre de priorité. Il s'agit d'un jeu de 40 cartes, dans la version française, chacune d'elles reprenant un souhait. (Voir Annexe 1).

Différents aspects sont abordés : « le patient lui-même, les soins techniques et physiques, les dimensions familiales, relationnelles et spirituelles, enfin, les conditions et l'organisation de la fin de vie ». (Mazzocato et Séchaud, 2016, p.111)

Cette façon de questionner le patient est moins formelle et plus attrayante. Celui-ci reste maître de son destin. Grâce à cette pratique, un dialogue va se créer entre soignant-soigné et une relation de confiance pourra s'installer. Le patient se sentira entendu et respecté dans ses volontés. (Mazzocato et Séchaud, 2016)

Dans ma situation, on peut constater que c'est cet accueil trop rapide qui a rendu la communication difficile. En effet, Madame est arrivée dans le service après avoir été opérée en urgence. Son hospitalisation dans ce dernier s'est ensuite déroulée sans qu'aucune question ne lui soit posée sur ses souhaits quant à celle-ci. Elle n'a, pour sa part, rien divulgué non plus quant à ses attentes. On peut donc en déduire que l'accueil s'est limité à une seule étape à savoir sécuriser la personne accueillie. La durée de l'hospitalisation, plus de trois semaines, n'a pas été mise à profit afin de mettre en place la deuxième étape de l'accueil : connaître la personne. Ce n'est qu'après son malaise que le nécessaire a été fait. Madame est donc décédée quelques jours plus tard à l'hôpital sans que l'on ait pu satisfaire ses souhaits.

Forte de ses constatations sur le projet de vie qui ne semble pas être interrogé par les soignants et sur l'accueil des patients qui peut se limiter à répondre aux besoins immédiats de ceux-ci liés à leur hospitalisation, j'ai voulu aller à la rencontre de personnes de terrain afin de savoir ce qui était fait dans la pratique. Il m'a semblé judicieux d'interviewer des infirmières pouvant prendre en charge des patients potentiellement en fin de vie ou atteint de maladies graves pouvant engager le pronostic vital à court ou moyen terme. À la suite de ces rencontres, j'aimerais constater ce qu'est pour elles le projet de vie, s'il est questionné dans leur service respectif, chez quel patient et surtout à quel moment il l'est. Enfin, pouvoir connaître le rôle de l'infirmière dans son questionnement. Après ses entretiens, mon objectif général serait de connaître la représentation que les infirmières ont de leur rôle par rapport au projet de vie ?

Les infirmières choisies pour la réalisation de cette enquête sont une travaillant dans un service général, une travaillant dans une unité de soins palliatifs, ayant également travaillé dans une unité de soins intensifs et enfin une exerçant en médecine interne, oncologie/hématologie. J'ai porté mon choix sur ces personnes car je voulais connaître les pratiques dans un service de soins généraux où peuvent également être hospitalisés des patients avec maladies graves où leur pronostic vital peut être engagé à court ou moyen terme, comme dans ma situation. Et les deux autres, pour leur expertise quant à la fin de vie omniprésente dans une unité de soins palliatifs et d'oncologie.

J'ai commencé mes entrevues par demander à chacune d'elles ce qu'elles entendaient par projet de vie. Pour l'infirmière en service de soins généraux, le projet de vie se limite à connaître les désirs du patient quant à ses traitements. Pour elle, il s'agit plus du projet thérapeutique du patient. Pour l'infirmière travaillant en soins palliatifs, elle voit le projet de vie comme une échelle de soins pour la prise en charge du patient avec en plus la connaissance des désirs du patient à réaliser (comme rentrer à son domicile) et son accompagnement. Enfin pour l'infirmière en oncologie, elle met en avant les volontés du patient concernant ses soins et également ses souhaits.

On peut donc constater que l'aspect médical est principalement mis en avant en ce qui concerne leur perception du projet de vie, bien qu'en oncologie et en soins palliatifs, les souhaits autres que thérapeutiques sont aussi abordés. Pour le service général, il y a clairement confusion entre le projet de vie et le projet thérapeutique.

J'ai continué ces entrevues en leur demandant si le projet de vie était abordé dans leur service et si oui à quel moment ? Pour les deux unités de soins spécialisés, c'est dès l'entrée dans le service que le patient est interrogé sur ses attentes, tant au niveau des soins que de ses désirs. Il n'y a pas vraiment d'outils, c'est au cas par cas en se basant sur l'échelle de soins et l'état de santé du patient. Cet accueil en soins palliatifs est toujours programmé, le personnel soignant prend le temps d'interroger le patient et sa famille sur leurs attentes et sur ce qu'ils savent de la maladie. Ils vont toujours dans le sens où le patient et son entourage veulent aller. Ce constat se retrouve dans le concept d'accueil dans lequel Formarier indique que l'accueil est indispensable à une bonne prise en soin afin que chaque partie puisse s'exprimer ouvertement et qu'une relation de confiance puisse s'installer (2006). Lors de cet accueil dans le service, c'est principalement, au départ l'aspect médical qui est abordé. Une échelle de soins est établie avec différents niveaux. Niveau 1 : soins de base, niveau 2 : soins de confort (palliatifs), niveau 3 : soins usuels (soins maximum excepté manœuvre de réanimation) et enfin niveau 4 : soins avancés (toutes mesures diagnostiques et thérapeutiques). Vient ensuite le questionnement sur les désirs autres que médicaux. Là, toute une équipe pluridisciplinaire (kiné, assistant social, psychologue, médecin, infirmière) se met en place afin de pouvoir réaliser les souhaits du patient, chacun avec sa spécificité. Le kiné pourra aider le patient à retrouver un minimum d'autonomie, l'assistante sociale pourra préparer un retour à la maison et les infirmières en plus des soins prodigués, pourront accompagner le patient sur son chemin de (fin de) vie. Ici, c'est donc vraiment le concept de projet de vie à court terme qui est constaté, aborder avec le patient ses souhaits immédiats en tenant compte de l'évolution de la maladie.

En oncologie, ils travaillent avec un système de codes couleurs. Selon l'évolution de la maladie et les choix du patient, une couleur lui sera attribuée. Lors de cette interview, je me suis rendu compte que l'infirmière mélangeait un peu projet de vie et projet thérapeutique car elle m'a principalement parlé des traitements qui pouvaient évoluer en même temps que la maladie.

Enfin, en ce qui concerne le service général, le projet de vie n'est pas abordé. D'autant plus que l'infirmière interrogée pense qu'il s'agit plutôt d'un projet thérapeutique. Elle sait tout de même, quand un patient rentre dans le service, si un projet thérapeutique a été établi car cela est indiqué dans son dossier informatique.

Je leur ai ensuite demandé chez quels types de patients elles estimaient nécessaire de mettre en place un projet de vie. Bien évidemment dans les deux services spécialisés, ce sont tous les patients qui doivent en bénéficier puisqu'ils vivent avec une maladie où leur pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, il est donc important de connaître et de respecter les choix du

patient. Quant au service général, l'infirmière n'a pas d'avis à ce sujet, les patients venant dans le service, sont souvent là pour un problème bien spécifique et généralement ne reste pas longtemps. On constate donc que ce sont plus les besoins immédiats du patient liés à son hospitalisation qui seront pris en compte dans un service général.

Pour terminer ces entretiens, j'ai voulu savoir quel était, selon elles, le rôle de l'infirmière dans le questionnement du projet de vie. Comme indiqué plus haut pour le service général, elle estime que l'infirmière ne doit pas intervenir, ce qui en soit est normal puisque pour elle, le projet de vie s'assimile au projet thérapeutique où c'est principalement le médecin qui doit intervenir. Pour le service d'oncologie, c'est assez mitigé, bien qu'elle estime devoir être là pour le patient, afin de l'épauler et l'accompagner, elle aussi pense que c'est au médecin de faire le nécessaire afin de connaître les désirs du patient. Enfin dans le service de soins palliatifs, c'est un travail collaboratif entre les différents acteurs de soins. L'infirmière est là afin de réexpliquer au patient ce que le médecin lui a déjà dit. Au cours du séjour, une relation de confiance s'installe, le patient se confie beaucoup auprès d'elle sur sa maladie, ses peurs et sa famille. Ces confidences sont rapportées lors d'une réunion hebdomadaire du staff afin que le projet de vie « colle » toujours bien aux attentes du patient. En cas de besoin, il est adapté.

A ce stade de mon travail, certaines questions me viennent à l'esprit :

- Le personnel infirmier, dans les services généraux, connaît-il vraiment la distinction entre projet de vie et projet thérapeutique ?
- Dans les services généraux, quelle représentation a le personnel infirmier de son rôle quant au questionnement du projet de vie ?

En faisant cette enquête exploratoire, je me suis rendu compte que le projet de vie dans les services généraux n'était pas connu ou plutôt confondu avec le projet thérapeutique, l'infirmière du service ne se sentant alors pas du tout investie d'une mission pour son questionnement/élaboration. Pourtant certains patients, présentant des pathologies lourdes laissant penser à une fin de vie proche à court ou moyen terme, sont parfois hospitalisés dans ce type de service. Même si au départ, on peut penser que ce ne soit pas nécessaire, il peut arriver que l'état de santé du patient se dégrade. Connaître ses souhaits et attentes semble donc important afin de les respecter. Comme dans ma situation, il aurait été utile, tant pour Madame, sa famille, que pour l'équipe soignante que l'on puisse l'interroger rapidement sur ses désirs afin de faire en sorte de les respecter.

Pour les services spécialisés où la mort est très présente, le projet de vie est abordé d'emblée avec le patient et sa famille mais je constate que les volontés tant au niveau des soins que des désirs sont discutées en équipe pluridisciplinaire. J'ai d'avantage l'impression que le rôle principal de l'infirmière est l'accompagnement du patient dans ce projet de vie. Être là afin de l'écouter, le rassurer, pouvoir répondre à ses questions.

Ce constat m'a amené à m'interroger sur le concept d'accompagnement, l'infirmière ayant donc un rôle à jouer dans l'accompagnement du patient afin de rendre sa fin de vie (plus ou moins proche) aussi sereine que possible, lui permettre de faire un cheminement vers ce qu'il désire vraiment.

Accompagner quelqu'un, c'est être là pour lui en tant que soutien, l'aider à affronter les épreuves de la vie. (Cifali et André, cités dans Mottaz, 2012)

Selon Verspieren (cité par Mottaz, 2012, p.42), accompagner quelqu'un ce n'est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître la direction qu'il va prendre ; mais c'est marcher à ses côtés en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme de son pas.

Le rôle du personnel soignant est d'être là afin d'aiguiller le patient et lui permettre de vivre en harmonie. L'important étant que ses choix soient respectés.

Afin d'y parvenir et d'avoir un accompagnement optimal, il devra faire preuve de bienveillance, d'écoute, de disponibilité et de respect envers la personne accompagnée. (Ennahou et Soenens, 2018)

Fontaine (2009, p.59) indiquera également que l'accompagnement infirmier met l'accent sur les ressources de la personne soignée qui mobilise autant l'expertise du soignant que celle du soigné. Certes l'expertise n'est pas de même nature, l'une est professionnelle, l'autre émerge de celle du soigné, mais la confrontation des deux, lorsqu'elles sont reconnues et positivement gérées, conduit à l'établissement d'un authentique dialogue soignant-soigné, sans oublier l'environnement familial ou autre selon les situations.

Cet aspect de l'accompagnement, à savoir le dialogue soignant-soigné, s'avère être primordial. Si une relation de confiance ne s'est pas installée, ce dialogue pourra difficilement s'instaurer.

Pour qu'un accompagnement soit efficace, il doit avoir certains attributs comme une bonne relation à l'autre (proximité), une bonne écoute, de la bienveillance et une relation de réciprocité, tout cela ayant pour objectif d'instaurer cette relation de confiance si importante et donner l'opportunité au patient de s'exprimer. (Mottaz, 2012)

Il est important que le soignant soit expert dans le domaine de l'accompagnement, cela afin que cette relation de confiance puisse s'installer. Pouvoir connaître le patient dans sa globalité et répondre à ses questions. (Fauré, 2016)

Dans la situation vécue, le dialogue entre Madame et l'équipe soignante était restreint, se limitant à de simples conversations durant les soins journaliers. L'accompagnement de Madame n'a jamais vraiment débuté. Aucune des parties n'ayant jugé opportun de discuter de l'avenir et de ce qu'elle désirait pour sa fin de vie.

3. Synthèse, questionnement professionnel et pistes de réflexion

C'est lors d'une nuit calme, lorsque je travaillais comme jobiste, que l'idée de ce sujet de TFE m'est venue. En effet, j'ai pu discuter avec l'infirmière du service de la non mise en place ou alors trop tardivement, lorsqu'une « crise » survenait, du projet thérapeutique chez des patients hospitalisés. J'ai ainsi pu me remémorer une situation identique vécue en stage où les désirs du patient n'avaient pas pu être mis en place.

Suite à ce constat du questionnement tardif des désirs du patient, mes recherches se sont orientées vers les compétences que devait présenter le personnel infirmier pour l'élaboration de projets. J'ai ensuite répertorié les principaux. En effectuant mes recherches, je me suis rendu compte que l'infirmière n'avait qu'un rôle « de relais » entre le patient et le médecin pour le questionnement du projet thérapeutique puisque ce sont uniquement les aspects médicaux qui sont abordés. J'ai alors analysé les principaux autres projets existants. Celui pour lequel, selon moi, l'infirmière peut jouer un rôle majeur dans son questionnement est le projet de vie car ce sont tous les aspects de la vie du patient qui sont pris en compte. J'ai donc décidé de m'intéresser à ce premier concept.

Ensuite, par l'analyse d'un article probant, j'ai pu constater que, dans la pratique, le personnel soignant était mal à l'aise par rapport au fait de questionner les patients potentiellement en fin de vie. Il estimait que ce n'était pas de son ressort, soit le faisait de façon non appropriée ou trop tard. De plus la charge et l'organisation du travail semble également problématique afin de connaître le patient et arriver à tisser une relation de confiance.

Suite à ce constat, je me suis intéressée aux autres concepts pouvant être utiles aux infirmières. Je me suis d'abord intéressée au concept d'accueil.

Par la suite, afin de vérifier ce qui était fait en pratique dans différents services (général, soins palliatifs et oncologie), j'ai réalisé une enquête exploratoire. J'ai alors rencontré trois infirmières, chacune m'a expliqué ce qui était fait dans son service respectif.

A la suite de ces entrevues, j'ai pu constater, dans le service général, que le projet de vie était assimilé au projet thérapeutique, l'infirmière ne se sent dès lors pas investie d'un rôle pour le questionner, pour elle, ce n'est pas de son ressort. En revanche, dans les deux unités de soins spécialisés (soins palliatifs et oncologie) où la mort est omniprésente, le patient est questionné dès son entrée dans le service. Une attention particulière est faite pour l'accueil où le nécessaire

est fait afin qu'une relation de confiance puisse s'installer entre les parties. Le personnel infirmier est également là afin d'accompagner le patient sur son chemin de (fin de) vie. Il prend le temps de le rassurer et répondre à ses questions. Grâce à cette enquête, je me suis aperçue que l'accompagnement des patients était très important. J'ai alors décidé d'analyser ce troisième concept.

Au terme de cette démarche de mon TFE, je me pose le questionnement professionnel suivant :

- Quels moyens mettre en place afin que le personnel infirmier, travaillant dans un service de soins généraux, se sente investi tôt assez dans le questionnement du projet de vie des patients présentant des pathologies engageant leur pronostic vital à court ou moyen terme ?

Plusieurs pistes de réponses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, l'accueil étant la première étape de la prise en soin, une « check-list » pourrait être établie et remplie systématiquement dès l'admission du patient dans le service afin de connaître en détail son état de santé. S'il est atteint d'une pathologie grave laissant présager une fin de vie à court ou moyen terme, le questionner sur ses désirs afin de savoir s'il avait déjà réfléchi à son projet de vie. L'accompagner ensuite vers ce qu'il souhaite mettre en place.

Pour que cela devienne automatique, une infirmière du service pourrait être une référente par rapport à ce questionnement du projet de vie. Certaines formations pourraient être suivies afin de lui permettre d'approfondir ses connaissances et avoir un autre regard sur la fin de vie à court ou moyen terme. Cela pourrait permettre d'instaurer plus facilement une relation de confiance entre le soignant et le soigné afin que ce dernier discute ouvertement de ses désirs.

Le jeu Go Wish, dont j'ai parlé plus haut dans ce travail, pourrait être une première étape à la prise de contact avec le patient.

Toutes ces pistes peuvent être des solutions afin que le personnel soignant questionne plus rapidement le patient sur son projet de vie. Cela éviterait de se retrouver comme dans ma situation de départ où les souhaits du patient ne peuvent être mis en place. Le temps et l'écoute accordés au patient restent essentiels et cela dès son entrée dans un service, quel qu'il soit.

La charge de travail et le manque récurrent de personnel permettent-ils vraiment le questionnement et la mise en place du projet de vie dans les services généraux ? Cette question mériterait d'être approfondie davantage.

Conclusion personnelle

Le choix du thème de mon TFE a été évident pour moi dès le départ, tellement la situation vécue en stage m'avait interpellée. Cela n'a cependant pas été facile car j'ai mis énormément de temps à mettre de l'ordre dans mes idées et à les structurer. Mes recherches documentaires ont également été longues et fastidieuses. Je ne pensais pas que mon thème serait si compliqué à développer. Malgré cela, je ne regrette absolument pas mon choix. Le questionnement et l'accompagnement du patient gravement malade dans l'élaboration de son projet de vie me semblait être un sujet important. Cet accompagnement des patients a toujours été pour moi important. Prendre le temps de dialoguer afin qu'ils se sentent écoutés et compris. L'accueil dans un service et l'accompagnement du patient sont pour moi des compétences infirmières essentielles. Cependant tout au long de mes recherches et/ou de mes rencontres, je me suis rendu compte que non seulement le projet de vie n'était pas souvent abordé mais également qu'il y avait confusion entre lui et le projet thérapeutique, du moins dans les services généraux où la mort est moins présente que dans un service de soins palliatifs ou d'oncologie. Moi-même au départ, je me suis d'abord concentrée sur le projet thérapeutique avant de me rendre compte, grâce à mes recherches, que l'infirmière n'avait pas un rôle significatif à jouer dans son questionnement.

Un point qui me semble pouvoir être amélioré dans ce TFE est la recherche d'articles scientifiques car je n'ai pas réussi à en trouver un qui corresponde complètement à ma thématique. Bien qu'il ait tout de même été pertinent, je n'ai pas su démontrer le rôle du soignant dans le questionnement de projet de vie proprement dit. Il n'y a que le questionnement au niveau thérapeutique qui ait été abordé.

Ce travail m'a conforté dans mon idée, à savoir qu'il est important de prendre le temps d'accueillir le patient et ce quel que soit le service dans lequel il est hospitalisé. Il en est de même pour son accompagnement afin d'instaurer cette relation de confiance si importante et de pouvoir élaborer son projet de vie. Cela est bénéfique pour tout le monde, autant pour le patient et sa famille que pour le personnel soignant. On retrouve ces pratiques en soins palliatifs et en oncologie. Il serait intéressant qu'elles soient appliquées dans les services de soins généraux quand l'état de santé du patient laisse penser à une fin de vie plus ou moins proche et que rien n'a encore été fait.

Pour conclure, je dirais tout d'abord que rédiger ce travail m'a appris à être mieux organisée et à cibler mes recherches, car il est vrai qu'au départ, j'avais tendance à partir dans tous les sens et à ne pas structurer mes idées. Même si je me suis souvent découragée, je suis heureuse d'avoir persévéré car ce travail m'a permis de mieux connaître le rôle de l'infirmière dans le questionnement du projet de vie. Je pourrai dès lors agir en conséquence dans ma future carrière professionnelle lorsque j'aurai à m'occuper de patients gravement malades ou potentiellement en fin de vie. Lors de mon enquête exploratoire, j'ai également pu rencontrer des personnes passionnées par leur métier. Pouvoir discuter de ce sujet avec elles a été très enrichissant tant au niveau professionnel qu'humain.

Liste de références

- Bay, C., Dancot, J., Jacquemin, N., Lebas, M-C., Maucq, S., Pirson, A. et Tison, T. (2020-2021). *Référentiel de compétences professionnelles du Bachelier Infirmier Responsable de Soins Généraux*. Document non publié, Haute Ecole Robert Schuman, Libramont, Belgique.
- Bourgeois, F. (2010). L'entretien d'accueil, une rencontre soignant-soigné : technique de soins. *La revue de l'infirmière*, 59 (163), 43-44.
- Carlin, N. (2017). Actualités médicales et soignantes : Des vœux pour sa fin de vie : avoir des cartes en mains... *Jusqu'à la mort accompagner la vie*, 131 (4), 87-94. <https://doi.org/10.3917/jalmalv.131.0087>
- Claes, E., Baio, V. et Courtin, Y. (2019). 35 recommandations pour accompagner la fin de vie au Grand Hôpital de Charleroi. *Louvain Medical*, 138 (8), 459-465. <https://www.louvainmedical.be/fr/article/35-recommandations-pour-accompagner-la-fin-de-vie-au-grand-hopital-de-charleroi>
- Coitout, C. et Lavault, I. (2021). Projet de (fin de) vie : un accompagnement par le soignant. *Médecine palliative*, 20 (6), 342-345. <https://doi.org/10.1016/j.medpol.2020.09.04>
- Conseil fédéral de l'art infirmier (CFAI). (2017 « mise à jour » 12/01/2018). *Code de déontologie des praticiens de l'art infirmier belges*. Récupéré du site SPF santé public, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/code_de_deontologie_des_praticiens_ai.pdf
- Dictionnaire médical. (s.d). *Directive anticipée*. Dans le dictionnaire médical en ligne. Consulté le 11 novembre 2021 sur <https://www.dictionnaire-medical.fr/definitions/073-directive-anticipee/>

- Ennahou, M. et Soenens J. (2018). Relation soignant/soigné dans l'approche palliative, quand tout reste à faire. *La revue des soins palliatifs en Wallonie*, (41), 19-25.
https://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/41trimestriel_1812_br.pdf?fbclid=IwAR1fxZsv4Cf3Ns3z1Tf6tb_fHH954mrE6flalWpG-mS12TWSM3tOuCBK6pg
- Fauré, C. (2016). *Accompagner un proche en fin de vie – Savoir l'écouter, le comprendre et communiquer avec les médecins*. Paris, France : Albin Michel.
- Formarier, M. (2003). Approche du concept d'accueil, entre banalité et complexité. *Recherche en soins infirmiers*, 75 (12), 15-20.
- Formarier, M. (2012). Accueil. Dans M. Formarier et L. Jovic (dir.). *Les concepts en sciences infirmières* (2^{ième} éd.) (pp. 43-45). Mallet Conseil.
<https://doi.org/10.3917/arsi.forma.2012.01.0043>
- Fontaine, M. (2009). L'accompagnement, un lieu nécessaire des soins infirmiers. *Pensée plurielle*, 3 (22), 53-63. <https://doi.org/10.3917/pp.022.0053>
- Fortin, G. (2017). *Parler des objectifs de fin de vie | une affaire d'équipe*. Spiritualitésanté. Récupérer le 24 janvier 2022 sur <https://www.chudequebec.ca/a-propos-de-nous/publications/revues-en-ligne/spiritualite-sante/dossiers/choisir-lors-de-situations-medicales-complexes/parler-des-objectifs-de-fin-de-vie-une-affaire-d.aspx>
- Guerrin, B. (2012). Projet de soins. Dans M. Formarier et L. Jovic (dir.). *Les concepts en sciences infirmières* (2^{ième} éd.) (pp. 317-318). Mallet conseil.
<https://doi.org/10.3917/arsi.forma.2012.01.0317>
- Halouët, P. (2021). Projet de soins infirmiers. Dans P. Halouët (dir.). *Toute l'année 1 du D.E.I. le cahier de l'étudiant infirmier* (2^{ième} éd.) (pp.434-445). Elsevier Masson.
- Haute autorité de santé. (2018). *Comment mieux accompagner les patients en fin de vie ?* Récupérer le 21 février 2022 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/presse_dp_reco_fin_de_vie.pdf

- Hebbelinck, T. et Hupé, A. (2020). *Projet de vie personnalisé et anticipé et projet anticipé de vie et de soins*. Unessa. Consulté le 15 décembre 2022 sur <http://unessa.be/getattachment/Homepage/Projets/PSPA-Page/PSPA-Documentation/WebinairePSPA-PAVS-200929.pdf.aspx?fbclid=IwAR1bPuEF>
- Jamet, F. (2006). Réflexions psychologiques sur la notion de « projet de vie ». *Journée régional ARAMI : « Projet personnalisé de scolarisation, Projet professionnel, Projet de vie »*. 14-18. Consulté le 15 novembre 2021 sur <http://paris-reasoning.eu/wp-content/uploads/2015/08/Jamet06-Projet-de-vie-.pdf>
- Larousse. (2012). *Projet*. Dans Le Petit Larousse Illustré.
- Loubat, J-R. (2010). *Projet de vie*. Service social et établissement medico-social. Consulté le 15 janvier 2022 sur <http://asesms.unblog.fr/2010/01/14/projet-de-vie/>
- Mazzocato, C. et Séchaud, L. (2016). Planification anticipée du projet thérapeutique et directives anticipées. *Bioethica Forum*, 9, 111-112. http://www.bioethica-forum.ch/docs/16_3/05_Mazzocato_BF9_03.pdf
- Mottaz, A-M. (2012). Accompagnement. Dans M. Formarier et L. Jovic (dir.). *Les concepts en sciences infirmières (2^{ième} éd.)* (pp. 42-43). Mallet Conseil. <https://doi.org/10.3917/arsi.forma.2012.01.0042>
- Tranmer, J.E. et Heyland, D. (2001). Le rôle décisionnel chez les patients hospitalisés gravement malades en fin de vie : la perspective du patient et celle du soignant. *Revue canadienne de nursing oncologique*, 11 (1), 14-20. Doi : 10.5737/1181912x1111420
- Vaysse-van Oost, C. (2019). *Actualités sur les Soins palliatifs*. Service de soins palliatifs et MCC. Consulté le 21 février 2022 sur <https://www.aframeco.be/system/files/actualites%20soins%20palliatifs.pdf>

Annexe 1 : Go Wish (Carlin, 2017, pp. 93-94)

			JOKER
1 Être soulagé de la douleur	2 Ne pas avoir d'angoisse	3 Maintenir ma dignité	4 Ne pas être essoufflé
5 Ne pas être branché à des machines	6 Avoir un contact humain	7 Avoir ma famille avec moi	8 Avoir quelqu'un qui m'écoute
9 S'occuper des affaires non réglées avec ma famille/mes amis	10 Pouvoir parler de ce qui me fait peur	11 Être conscient jusqu'au bout	12 Avoir un médecin qui me connaît et me comprend

13 Avoir confiance en mon médecin	14 Avoir une personne qui connaît mes valeurs et priorités	15 Pouvoir dire adieu aux personnes qui comptent pour moi	16 Ne pas être une charge pour ma famille
17 Avoir des soignants avec lesquels je me sente à l'aise	18 Garder mon sens de l'humour	19 Avoir préparé mes obsèques	20 Avoir le sentiment que ma vie a un sens
21 Ne pas mourir seul	22 Être traité selon mes souhaits	23 Être endormi à la fin	24 Rester propre
25 Être capable d'aider les autres	26 Prévenir les conflits en m'assurant que ma famille sait ce que je veux	27 Avoir ma famille préparée à ma mort	28 Avoir des amis proches à mes côtés
29 Être capable de parler de ce que la mort signifie	30 Mourir chez moi	31 Être accompagné sur le plan religieux ou spirituel	32 Avoir mes affaires financières en ordre
33 Savoir comment ma maladie va évoluer et comment mon corps va changer	34 Être en paix avec Dieu	35 Méditer/prier	36 Être en paix avec moi-même
37 Pouvoir prendre les décisions qui me concernent jusqu'au bout	38 Être le premier informé de ma situation	39 Pouvoir choisir qui me voit si je suis très dégradé	40 Donner mes organes

Je soussignée **Remy Lise** (Nom(s) et Prénom(s) de (des) l'étudiant(e)(s)) autorise/ ~~n'autorise pas~~ (biffer la mention incorrecte) les membres de la Cellule d'Encadrement Méthodologique des Travaux de Fin d'Etudes à utiliser la version électronique de mon Travail de Fin d'Etudes et ce à des fins pédagogiques.

Date et signature(s) (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Lu et approuvé, le 25 mai 2022

Lise Remy